

WIREFRAME FUNCIONAL

Perfil Medicina

Plataforma asistencial y de comunicación con familias

Campo	Definición
Versión	v0.1 · Documento consolidado para prototipo
Fecha	23 de agosto de 2026
Base funcional	PRD v0.1-r2 + Wireframe Auxiliar v0.1 + Wireframe Enfermería v0.1 + decisiones cerradas durante la revisión del perfil médico
Ámbito	Residencias geriátricas · prototipo con datos ficticios
Estado	Cerrado funcionalmente para construir el prototipo navegable

Principio rector. El perfil médico permite valorar eventos que requieren intervención médica, documentar hallazgos, conducta, indicaciones, seguimiento, circuitos urgentes y cierre, manteniendo autoría y trazabilidad. En v0.1 no se define todavía como sustituto de la historia clínica oficial del centro, aunque la arquitectura deberá permitir una evolución futura hacia un registro asistencial longitudinal más completo.

Regla de seguridad. La plataforma no diagnostica, prescribe, solicita pruebas ni recomienda tratamientos de forma automática, y no sustituye los canales urgentes ni los protocolos asistenciales del centro.

1. Decisiones funcionales cerradas

Decisión	Definición funcional
Escalado	Medicina recibe eventos escalados por Enfermería y eventos creados directamente por Medicina.
Autoría	Observación y valoraciones previas permanecen intactas. Cada profesional firma únicamente su propia actuación.
Indicaciones	Generan tareas para Enfermería. Lectura y realización son hitos distintos.
Indicaciones pendientes	Si el resultado es necesario para decidir el desenlace, el evento permanece en seguimiento médico.
Vencimiento	Un seguimiento fuera de plazo no caduca ni desaparece: permanece pendiente y destacado hasta actuación profesional.
Continuidad	Al finalizar turno: transferir al equipo entrante o dejar en seguimiento para próxima revisión médica.
Derivación	Enfermería y Medicina reutilizan el mismo módulo de informe. El informe externo no incluye servicios contactados ni horas.
Familia	Si Medicina cierra, decide y aprueba directamente la comunicación familiar, sin revisión redundante de Enfermería.
Correcciones	Ventana ordinaria de 6 h por defecto, configurable por centro, solo por el autor. Después: rectificación trazable.
Línea temporal	No permanece desplegada. Se consulta mediante acción secundaria por perfiles autorizados.
Basal	Medicina consulta el basal vigente y solo puede reevaluarlo si el centro lo autoriza.
Historia clínica	v0.1 no se declara sustituto de la historia clínica oficial; se preserva una arquitectura evolutiva hacia registro longitudinal.

2. Mapa funcional del perfil médico

Paso	Bloque	Resultado
1	Inicio	Escalados, seguimientos, indicaciones y comunicaciones pendientes.
2	Revisión	Evento original, basal vigente, valoración de Enfermería y trazabilidad consultable.
3	Valoración	Hallazgos/exploración, valoración médica, constantes y actuaciones.
4	Conducta	Indicaciones, seguimiento, protocolo urgente o cierre.
5	Continuidad	Revisión de resultados, seguimiento y transferencia entre turnos.
6	Salida	Cierre asistencial e información familiar.
7	Consulta	Residentes, historial, basal y línea temporal completa.

3. Estados principales

Estado	Significado
Pendiente de valoración médica	Escalado recibido sin valoración médica iniciada.
En valoración médica	Un médico está documentando; otros autorizados

	consultan.
Indicaciones emitidas	Existen tareas médicas dirigidas a Enfermería.
En seguimiento médico	Requiere reevaluación posterior por fecha o criterio.
Pendiente fuera de plazo	La fecha/criterio previsto ha vencido; el evento sigue abierto y visible.
Pendiente de continuidad médica	Finalizó el turno del profesional en curso y queda continuidad pendiente.
Protocolo urgente	Circuito urgente/derivación documentado.
Cerrado por Medicina	Cierre asistencial firmado; pasa a Historial.

MED-01. Inicio de Medicina

Objetivo: Mostrar en una sola vista los asuntos médicos que requieren atención.

CENTRO RESIDENCIAL X · UNIDAD 2

Medicina · Dr. Juan Pérez [Salir]

REQUIERE ATENCIÓN

3 Escalados pendientes · 2 Seguimientos · 1 Indicación con incidencia

1 Comunicación familiar pendiente

[+ REGISTRAR NUEVO EVENTO CLÍNICO]

[ESCALADOS] [SEGUIMIENTOS] [INDICACIONES]

[APROBACIONES FAMILIARES] [RESIDENTES] [HISTORIAL]

- Los contadores incluyen únicamente residentes/unidades autorizados.
- Orden operativo: escalados pendientes; abiertos fuera de plazo; seguimientos previstos/vencidos; incidencias de indicaciones; comunicaciones pendientes.
- El sistema puede ordenar por antigüedad y estado administrativo, pero no prioriza clínicamente pacientes ni recomienda conducta.

MED-02. Bandeja de escalados

Objetivo: Visualizar eventos enviados desde Enfermería que requieren valoración médica.

ESCALADOS A MEDICINA

Filtros: Unidad · Residente · Estado · Antigüedad · Profesional en curso

MARÍA GARCÍA · 86 años

Motivo: Somnolencia + disminución de ingesta

Escalado por Marta Pérez · Enfermería · 19:10

Últimas constantes: Tª 38,2 °C · PA 118/64 · FC 96 · SpO₂ 95 % AA

Estado: Pendiente [VALORAR]

- Cada tarjeta muestra identidad, observación resumida, motivo de escalado, últimas constantes, actuaciones, tiempo y estado.
- No genera resúmenes diagnósticos automáticos.
- Si ha vencido un plazo administrativo o de revisión, se muestra «Pendiente fuera de plazo» sin retirar el caso.

MED-03. Detalle del escalado recibido

Objetivo: Reunir el contexto relevante sin modificar registros previos.

Plataforma asistencial y de comunicación con familias

DETALLE DEL EVENTO
MARÍA GARCÍA · 86 años · Unidad 2 · PENDIENTE DE VALORACIÓN MÉDICA

OBSERVACIÓN ORIGINAL - NO EDITABLE
[autor · fecha/hora · contenido]

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA - NO EDITABLE
[valoración · constantes · actuaciones]

MOTIVO DEL ESCALADO
[texto]

ESTADO BASAL VIGENTE
Barthel 65/100 · CFS 6 · Demencia Alzheimer · GDS 5
[VER BASAL COMPLETO]

TRAZABILIDAD DEL EVENTO
Última actuación: Escalado a Medicina · 19:10
[VER LÍNEA TEMPORAL COMPLETA]

[EMPEZAR VALORACIÓN MÉDICA]

- Medicina no edita observaciones, valoraciones, constantes ni motivos registrados por otros profesionales.
- La línea temporal completa se mantiene plegada por defecto.

MED-04. Inicio de valoración médica

Objetivo: Registrar quién inicia la actuación sin convertir el evento en propiedad permanente.

[EMPEZAR VALORACIÓN MÉDICA]

Estado → EN VALORACIÓN MÉDICA
En valoración por Dr. Juan Pérez · 19:18

- Se registra médico y hora de inicio.
- Se protege frente a edición simultánea; otros médicos autorizados pueden consultar.
- Al finalizar turno, la continuidad se transfiere o se deja en seguimiento.

MED-05. Valoración médica

Objetivo: Documentar exclusivamente la aportación médica nueva.

VALORACIÓN MÉDICA

HALLAZGOS / EXPLORACIÓN *
[.....]

VALORACIÓN MÉDICA *
[.....]

CONSTANTES ADICIONALES - OPCIONALES
Tª [] °C · PA []/[] mmHg · FC [] lpm · FR [] rpm
SpO₂ [] % ○ AA ○ Oxigenoterapia · Flujo [] L/min
Glucemia [] mg/dL · Otra [nombre] [valor] [unidad]

ACTUACIONES REALIZADAS
[.....]

[GUARDAR BORRADOR] [CONTINUAR A CONDUCTA]

- Se mantienen cuatro bloques principales: hallazgos/exploración, valoración médica, actuaciones y conducta.
- Las nuevas constantes se añaden como registros con autor y fecha/hora.
- La aplicación valida formato/unidades, pero no interpreta valores ni propone diagnósticos, pruebas o tratamientos.

MED-06. Conducta médica

Objetivo: Definir actuaciones intermedias y salida principal del evento.

CONDUCTA MÉDICA

Actuaciones intermedias:

- ☐ Registrar actuaciones médicas
- ☐ Emitir indicación a Enfermería

Salida principal:

- ☐ Cerrar tras valoración médica
- ☐ Mantener en seguimiento médico
- ☐ Activar / documentar protocolo urgente

[VOLVER] [CONTINUAR]

- Una indicación no implica cierre.
- Si el resultado de una indicación es necesario para decidir el desenlace, el evento debe mantenerse en seguimiento.

MED-07. Indicaciones a Enfermería

Objetivo: Comunicar una actuación concreta y conocer posteriormente su estado.

NUEVA INDICACIÓN A ENFERMERÍA

Indicación *

[.....]

Fecha prevista o criterio de realización

[.....]

Información adicional

[.....]

[FIRMAR Y ENVIAR]

- No existe selector de prioridad.
- Estado inicial: Pendiente de lectura.
- Estados: Pendiente de lectura → Leída → Realizada, o No realizada / incidencia.
- Confirmar lectura no equivale a registrar realización.

MED-08. Seguimiento de indicaciones emitidas

Objetivo: Permitir a Medicina conocer lectura, ejecución e incidencias.

INDICACIONES DEL EVENTO

1. Indicación · 20:10 · Dr. Juan Pérez

Estado: REALIZADA

Leída por: Marta Pérez · 20:14

Realizada por: Marta Pérez · 20:32

Nota de ejecución: [...]

2. Indicación · 20:20

Estado: NO REALIZADA / INCIDENCIA

Motivo: [...]

[NUEVA INDICACIÓN] [NUEVA VALORACIÓN]

[MANTENER SEGUIMIENTO] [CERRAR EVENTO]

- El cierre solo procede cuando el médico considere resuelto el episodio.
- Las incidencias quedan vinculadas a la indicación y al evento.

MED-09. Regla de indicaciones pendientes

Objetivo: Evitar cerrar episodios cuyo resultado pendiente sea necesario para decidir su desenlace.

Valoración médica

↓

Indicación a Enfermería

↓

Pendiente / realizada

↓

Seguimiento médico

↓

Resultado disponible

↓

Revaloración → seguimiento o cierre

- La plataforma no determina qué resultados son clínicamente necesarios; lo decide el médico.
- El evento permanece abierto hasta la reevaluación cuando el resultado sea necesario para el desenlace.

MED-10. Crear seguimiento médico

Objetivo: Mantener abierto un evento que requiere revisión posterior.

CREAR SEGUIMIENTO MÉDICO

Motivo * [.....]

Qué debe revisarse * [.....]

Fecha prevista o criterio de revisión * [.....]

Equipo responsable: Medicina · Unidad 2

[FIRMAR Y CREAR SEGUIMIENTO]

- Debe existir fecha o criterio de revisión.
- El responsable de continuidad es el equipo autorizado; cada actuación conserva autor individual.

MED-11. Bandeja de seguimientos médicos

Objetivo: Mantener visibles todos los seguimientos hasta su cierre.

SEGUIMIENTOS MÉDICOS

Filtros: Unidad · Hoy · Próximos · Fuera de plazo · Residente

MARÍA GARCÍA · 86 años

Revisión prevista: 22/08/2026 09:00

Estado: PENDIENTE FUERA DE PLAZO

Última actuación: Indicación realizada · 22:20

[REVISAR]

- Un seguimiento fuera de plazo no caduca ni desaparece.
- Se destaca mediante texto/icono además de color.
- Desde aquí se puede valorar, emitir indicación, mantener seguimiento, documentar protocolo urgente o cerrar.

MED-12. Continuidad entre médicos

Objetivo: Resolver el final de turno con un evento abierto.

FINALIZAR TURNO CON EVENTO ABIERTO

- ☐ Transferir continuidad al siguiente turno/equipo médico
- ☐ Dejar en seguimiento para próxima revisión médica

Situación actual * [.....]

Pendiente * [.....]

Fecha prevista o criterio * [.....]

[CONFIRMAR]

- Si hay relevo: queda «Pendiente de continuidad médica» y el siguiente profesional puede «Asumir continuidad».
- Si no hay relevo y procede reevaluación posterior: queda en seguimiento para la próxima presencia médica.
- El profesional saliente deja de figurar como médico activo del formulario.

MED-13. Protocolo urgente

Objetivo: Documentar el circuito urgente realmente realizado.

ACTUACIÓN URGENTE

Este registro no sustituye la atención inmediata ni el protocolo del centro.

Circuito/protocolo activado * [.....]

Actuaciones realizadas * [.....]

Profesional/servicio contactado * [.....]

Canal: ☐ Presencial ☐ Teléfono ☐ Emergencias ☐ Otro

Hora del aviso [:]

Situación actual * [.....]

[GUARDAR ACTUACIÓN URGENTE]

[GENERAR INFORME DE DERIVACIÓN]

- Los datos de contactos/horas permanecen en la trazabilidad interna cuando se registren.
- No se trasladan como bloque específico al informe externo de derivación.

MED-14. Informe de derivación a Urgencias

Objetivo: Generar un documento clínico trazable reutilizando el mismo módulo de Enfermería y Medicina.

VISTA PREVIA DEL INFORME DE DERIVACIÓN

Identificación del residente y centro
 Estado basal relevante · Barthel · CFS · cognición/comunicación
 Motivo de derivación y observación inicial
 Valoración de Enfermería y constantes
 Valoración médica, si existe
 Actuaciones realizadas
 Oxigenoterapia, si procede
 Evolución
 Profesional firmante

[EDITAR CAMPOS PERMITIDOS]
 [GUARDAR BORRADOR]
 [FIRMAR Y GENERAR PDF]

- Vista previa obligatoria.
- Editar el informe no modifica los registros de origen.
- El PDF firmado queda vinculado al evento.
- Se elimina del informe externo el bloque «servicios contactados y horas»; esos datos pueden conservarse en trazabilidad interna.

MED-15. Cierre médico del evento

Objetivo: Firmar formalmente la finalización del episodio médico.

CIERRE ASISTENCIAL

Resumen del episodio [solo lectura]
 Observación inicial · Valoración Enfermería · Valoración médica
 Actuaciones / indicaciones · Resultado

NOTA DE CIERRE *
 [.....]

ESTADO FINAL *
 [Seleccionar]

[VOLVER Y EDITAR] [FIRMAR CIERRE ASISTENCIAL]

- El evento queda Cerrado por Medicina, sale de bandejas activas y pasa a Historial.
- Enfermería no realiza un cierre redundante.
- Se abre la decisión sobre comunicación familiar.

MED-16. Decisión sobre comunicación familiar

Objetivo: Determinar si el evento cerrado por Medicina genera información familiar.

COMUNICACIÓN FAMILIAR

¿Debe este evento generar información para la familia?
☐ Sí, preparar comunicación

☐ No comunicar este evento

Si NO: Motivo * [.....]

[CONTINUAR]

- No comunicar no elimina ni oculta el evento interno.
- La decisión y el motivo quedan auditados.
- Autorizaciones familiares siguen gestionadas por Administración.

MED-17. Redacción y aprobación familiar

Objetivo: Crear y aprobar un texto separado en lenguaje sencillo.

PREPARAR COMUNICACIÓN

REFERENCIA INTERNA - NO PUBLICABLE

[evento · valoraciones · actuaciones · resultado]

INFORMACIÓN QUE VERÁ LA FAMILIA *

[.....]

AUDIENCIA AUTORIZADA - SOLO CONSULTA

Ana García · Hija · Autorización activa · Frecuencia semanal

[GUARDAR BORRADOR] [NO PUBLICAR]

[APROBAR PARA PUBLICACIÓN SEGÚN FRECUENCIA]

- El sistema no copia automáticamente el texto clínico interno.
- Se conserva texto exacto, médico aprobador, fecha, audiencia y versión.
- La aprobación no implica publicación inmediata; respeta la frecuencia configurada.
- El email externo, si existe, solo contiene aviso genérico al portal seguro.

MED-18. Evento iniciado directamente por Medicina

Objetivo: Registrar un episodio observado directamente por el médico sin circuitos artificiales.

NUEVO EVENTO CLÍNICO

1. Seleccionar residente y confirmar identidad

2. Motivo / hecho observado *

3. Hallazgos / exploración *

4. Valoración médica *

5. Constantes opcionales

6. Conducta:

☐ Actuaciones

☐ Indicación a Enfermería

☐ Cerrar

☐ Seguimiento

☐ Protocolo urgente

[GUARDAR BORRADOR] [CONTINUAR]

- Medicina figura como observador original.
- No se crea una tarea ficticia de revisión para Enfermería.
- Si necesita actuación de Enfermería, se crea una indicación independiente.

MED-19. Lista de residentes

Objetivo: Acceder a fichas y eventos de residentes autorizados.

RESIDENTES
Filtros: Unidad · Eventos abiertos · Seguimiento médico

MARÍA GARCÍA · 86 años · Mujer · Unidad 2
Basal: Barthel 65/100 · CFS 6
Eventos abiertos: 1 · Seguimientos médicos: 1
[ABRIR FICHA]

[+ REGISTRAR NUEVO EVENTO CLÍNICO]

- No se muestran residentes fuera de asignación/autorización.

MED-20. Ficha médica del residente

Objetivo: Centralizar contexto y acceso a la información asistencial generada en la plataforma.

FICHA DEL RESIDENTE

MARÍA GARCÍA · 86 años · Mujer · Unidad 2

ESTADO BASAL VIGENTE
Barthel 65/100 · CFS 6 · Demencia Alzheimer · GDS 5
[VER BASAL COMPLETO]

REGISTRO COTIDIANO
EVENTOS ABIERTOS
SEGUIMIENTOS MÉDICOS
INDICACIONES ABIERTAS

[REGISTRAR EVENTO CLÍNICO]
[HISTORIAL DE EVENTOS]

- En v0.1 no se define como sustituto de la historia clínica oficial del centro.
- Debe diseñarse para poder evolucionar en el futuro hacia un registro asistencial longitudinal más completo si el producto y la validación jurídica/técnica lo requieren.

MED-21. Consulta y reevaluación del estado basal

Objetivo: Consultar el basal vigente y reutilizar el módulo de reevaluación cuando el centro lo autorice.

- Medicina puede consultar movilidad, alimentación, continencia, aseo/higiene, cognición, comunicación, conducta, sueño, ayudas, Barthel, CFS, situación cognitiva, etiología/GDS documentados, fecha, autor, fuente y motivo.
- «Reevaluar basal» solo aparece con permiso del centro.
- Se reutiliza el mismo módulo diseñado para Enfermería; no se crea una variante médica.

MED-22. Historial de eventos

Objetivo: Consultar episodios abiertos/cerrados y reconstruir su trazabilidad.

HISTORIAL DE EVENTOS

Filtros: Residente · Fecha · Categoría · Autor · Profesional de cierre
Estado final · Derivación · Comunicación familiar · Ordinario/Prioritario

MARÍA GARCÍA · 10/08/2026
Evento prioritario · Cerrado por Medicina
Derivación: Sí · Informe disponible · Comunicación: aprobada
[VER DETALLE]

- Es de solo lectura.
- Incluye observación, Enfermería, escalado, Medicina, indicaciones, lectura/ejecución, seguimientos, urgencia, informes, cierre y publicación.
- Medicina consulta únicamente residentes/unidades autorizados.

MED-23. Corrección y rectificación de registros médicos

Objetivo: Permitir subsanar errores sin destruir el registro original.

DENTRO DE LAS PRIMERAS 6 h (valor por defecto configurable)
[CORREGIR REGISTRO PROPIO]

Registro original [solo lectura]
Motivo * [.....]
Nueva versión * [.....]
[FIRMAR CORRECCIÓN]

FUERA DE LA VENTANA
[AÑADIR RECTIFICACIÓN]

Rectificación * [.....]
Motivo * [.....]
[FIRMAR RECTIFICACIÓN]

- La corrección ordinaria solo está disponible para el mismo profesional que escribió el registro y dentro de la ventana configurada; referencia inicial: 6 horas.
- Original y versiones se conservan con autor, fecha/hora y motivo.
- Fuera de la ventana no se modifica retrospectivamente: se añade una rectificación vinculada.
- Las políticas definitivas deben validarse con el centro y requisitos jurídicos/documentales antes de producción.

MED-24. Línea temporal completa

Objetivo: Consultar la cronología solo cuando sea necesaria, sin ocupar permanentemente la pantalla.

TRAZABILIDAD DEL EVENTO
Última actuación:
Valoración de Enfermería · Marta Pérez · 18:50

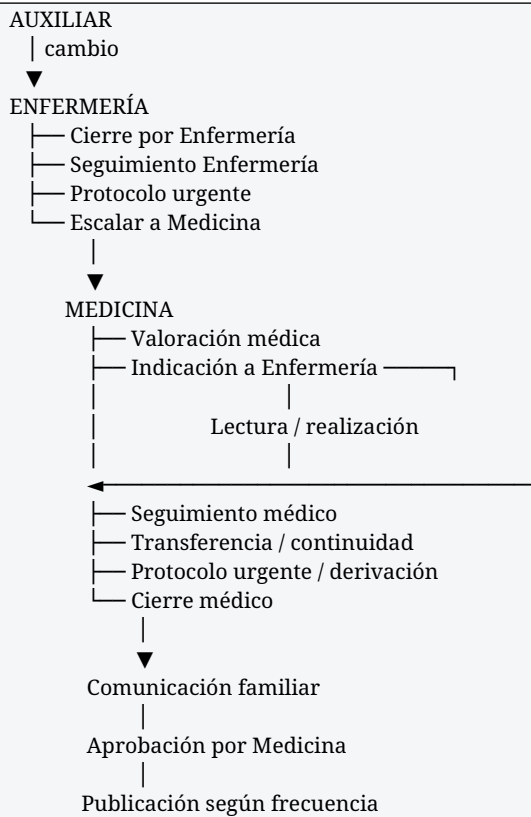
[VER LÍNEA TEMPORAL COMPLETA]

→ Al abrir:
18:31 · Auxiliar · Observación
18:36 · Enfermería · Inicio valoración
18:50 · Enfermería · Valoración
19:10 · Escalado a Medicina
19:18 · Medicina · Inicio valoración
19:35 · Indicación

20:05 · Enfermería · Realizada
 20:30 · Medicina · Revaloración
 20:40 · Medicina · Cierre
 20:45 · Comunicación aprobada

- Enfermería: eventos de unidades autorizadas.
- Medicina: eventos de residentes/unidades autorizados.
- Dirección/Coordinación: solo si el futuro perfil administrativo concede expresamente esa función.
- Auxiliar: sin acceso general a la cronología clínica completa.
- Familia: sin acceso a trazabilidad interna.

4. Flujo funcional consolidado



5. Límites del perfil médico

Medicina puede

- Consultar residentes autorizados y su basal vigente.
- Recibir escalados de Enfermería y registrar eventos propios.
- Registrar valoración, constantes adicionales, actuaciones e indicaciones.
- Consultar lectura, ejecución e incidencias de indicaciones.
- Mantener seguimientos y transferir continuidad.
- Documentar protocolos urgentes y generar el informe compartido de derivación.
- Cerrar eventos asumidos y aprobar su comunicación familiar.
- Consultar historial y línea temporal completa dentro de sus permisos.

- Corregir registros propios dentro de la ventana configurada y añadir rectificaciones posteriores.
- Reevaluar el basal solo cuando el centro lo autorice.

Medicina no puede

- Modificar observaciones o valoraciones firmadas por otros profesionales.
- Atribuir actuaciones a otro profesional.
- Recibir diagnósticos, pruebas o tratamientos propuestos automáticamente por la plataforma.
- Utilizar la v0.1 como sistema de prescripción electrónica.
- Acceder a residentes no autorizados.
- Modificar autorizaciones familiares.
- Publicar información familiar sin aprobación expresa.
- Borrar o sobrescribir silenciosamente registros firmados.
- Usar el cierre para ocultar tareas o resultados pendientes necesarios para decidir el desenlace.

6. Criterios de aceptación del prototipo

- ☐ Medicina ve únicamente escalados y residentes autorizados.
- ☐ El escalado muestra observación original y valoración de Enfermería sin permitir modificarlas.
- ☐ Al comenzar una valoración se registra médico y hora.
- ☐ La valoración médica y las constantes nuevas conservan autoría y momento de registro.
- ☐ La plataforma no genera diagnósticos, pruebas ni tratamientos.
- ☐ Las indicaciones no tienen selector de prioridad y utilizan estado + fecha/criterio.
- ☐ Lectura y realización de una indicación son estados distintos.
- ☐ Si un resultado es necesario para decidir el desenlace, el evento puede mantenerse en seguimiento hasta reevaluación.
- ☐ Los seguimientos fuera de plazo no caducan ni desaparecen.
- ☐ Al finalizar turno se puede transferir continuidad o dejar seguimiento para próxima revisión.
- ☐ Medicina puede iniciar un evento directamente sin reenviarlo artificialmente a Enfermería.
- ☐ Si Medicina cierra, Enfermería no realiza un segundo cierre.
- ☐ El cierre médico abre la decisión de comunicación familiar.
- ☐ El botón familiar usa exactamente «Aprobar para publicación según frecuencia».
- ☐ El informe de derivación es compartido con Enfermería y no incluye «servicios contactados y horas» como bloque externo.
- ☐ Los eventos cerrados salen de bandejas y permanecen en Historial.
- ☐ La línea temporal completa se abre bajo demanda y respeta permisos.

- ☐ Las correcciones conservan el original; ventana inicial de 6 h configurable y rectificación posterior trazable.
- ☐ No existe acceso médico a residentes fuera de asignación/autorización.

7. Pendientes trasladados fuera del wireframe médico

- Actualizar el PRD en una revisión posterior para reflejar las decisiones consolidadas de Enfermería y Medicina, incluida la evolución potencial hacia un registro asistencial longitudinal.
- Actualizar ENF-12 para eliminar «servicios avisados/contactados y horas» del informe externo de derivación, manteniendo la trazabilidad interna.
- Validar con centro piloto y asesoría/DPO la política definitiva de correcciones/rectificaciones y su ventana temporal.
- Definir en el futuro perfil de Dirección/Coordinación si dispone de acceso de supervisión a líneas temporales clínicas y con qué alcance.

8. Referencias funcionales del proyecto

- PRD_Plataforma_contacto_familias_v0.1-r2.docx.
- Wireframe_funcional_Auxiliar_v0.1.docx.
- Wireframe_funcional_Enfermeria_v0.1.docx.
- AGENTS_Plataforma_residencias_v1.0.docx.
- Decisiones cerradas durante la revisión del wireframe médico, 23/08/2026.

Advertencia de uso. Este wireframe define el comportamiento funcional del prototipo. No constituye un protocolo clínico, una historia clínica homologada, una EIPD, una validación jurídica ni una autorización para tratar datos reales.